

42 - Procidence du Cordon - Pr. AIT BENKADDOUR

Ceci est un cours sur la procidence du cordon destiné aux étudiants de cinquième année des études médicales dans le cadre du module de gynécologie obstétrique de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Donc la procidence du cordon étant définie comme la chute du cordon ombilical au devant de la présentation foetale, c'est-à-dire qu'au cours de la dilatation et cours du travail ou de l'accouchement, le cordon ombilical se présente et est extériorisé au devant de la présentation du fœtus. C'est un accident qui est rare, heureusement, puisque c'est un accident aussi qui est grave et constitue une urgence diagnostique et thérapeutique, puisqu'il est associé à une proportion de morbidité et de mortalité néonatale très élevée, de l'ordre de 15 à 20% de décès natals, d'où l'intérêt d'un diagnostic très rapide et une prise en charge adaptée et très rapide.

Donc la procidence complique pratiquement 0,5% des grossesses, cependant ce pourcentage est variable en fonction des services des pays. Certains facteurs peuvent être considérés comme favorisant ou des facteurs de risque. Tous ces facteurs tournent autour d'une mauvaise accommodation de la présentation au segment inférieur et au détroit supérieur, ce qui laisse de l'espace latéral ou au devant de la présentation qui va laisser de l'espace pour passer le cordon ombilical et passer au devant de la présentation.

Les facteurs favorisant peuvent être d'ordre ovulaire, maternel ou iatrogène. Donc d'ordre ovulaire, les présentations irrégulières qui vont entraîner une mauvaise accommodation du mobile fœtal au détroit supérieur, comme la présentation de siège, la présentation transverse, la présentation de sommet mal fléchi, la présentation de face. La prématurité, vu que le mobile fœtal a un volume moindre qu'habituellement et donc qu'il y aura un risque de passage du cordon au devant.

Donc les grossesses multiples, le placenta bas inséré du fait que le placenta d'abord va empêcher l'accommodation du mobile fœtal au détroit supérieur et deuxièmement la proximité de l'insertion du cordon sur le placenta du col utérin. L'hydramnios par l'hyperpression qu'il va entraîner et donc qu'il va chasser le cordon ombilical avec la rupture de la poche des os et deuxièmement parce que l'hydramnios va aussi favoriser la mauvaise accommodation, la rupture prématurée des membranes parce que la rupture va se faire avant le moment où la tête s'est positionnée sur le détroit supérieur et a comblé l'espace entre le détroit supérieur et le col utérin. Donc les causes maternelles, c'est les bassins rétrécis, la multiparité, les placentas prévias.

Les causes iatrogènes, c'est une rupture ou une aminotomie, une rupture de la poche des os ou une aminotomie qui est faite de manière intempestive en dehors des conditions favorables, c'est-à-dire faites alors que la présentation ne s'est pas encore appliquée sur le détroit supérieur. La physiopathologie, donc la procidence du cordon, on a compris comment elle peut survenir. Alors lorsque elle survient, cette procidence du cordon va entraîner une compression du cordon entre la présentation et les éléments du bassin, que ce soit le bassin osseux ou le bassin mou, et elle

va entraîner une asphyxie fœtale.

Donc cette asphyxie fœtale, elle est secondaire, comme on a dit, à la compression des veines et des artères. Aussi, lorsque c'est une procédance avec extériorisation du cordon, il y aura un phénomène de desiccation du cordon et parfois, suite à un arrêt cardiaque fœtal, réflexe, surtout si ce cordon a été palpé, touché, manipulé par l'équipe soignante ou par la patiente elle-même ou son entourage. Donc on voit sur ce schéma-là que le cordon est extériorisé, il est au-devant de la présentation, cependant il est pratiquement juste au niveau du col et il n'est pas extériorisé du vagin.

Sur ce schéma, un stade un petit peu plus avancé de la procédance du cordon, le cordon est au niveau vaginal et il affleure l'orifice vulvaire. Dans certains cas, ce cordon peut être totalement extériorisé et ce qui expose, comme on l'a dit, à une desiccation et à un risque d'arrêt cardiaque fœtal, réflexe. Donc le diagnostic est essentiellement clinique.

Dans la forme typique, la procédance est découverte suite à une amniotomie, soit un examen qui a suivi l'amniotomie ou bien juste à titre systématique, l'examen au toucher vaginal va retrouver le cordon ombilical qui est au-devant de la présentation. Donc le diagnostic parfois est fait par inspection, par l'équipe soignante ou même par la patiente lorsque c'est un stade 3, c'est-à-dire qu'il est totalement extériorisé ou parfois on le découvre suite à des anomalies de RCF, d'où l'intérêt toujours d'avoir ce réflexe de faire un toucher vaginal lorsque l'on a une anomalie non expliquée du rythme cardiaque fœtal, il faut toujours faire le toucher vaginal qui va permettre le diagnostic positif d'une procédance méconnue et il va améliorer le pronostic parce que le diagnostic précoce est la clé du pronostic. Donc la classification qu'on a déjà citée, c'est le cordon en intravaginal, c'est le degré 1, le degré 2 correspond à un cordon qui affleure la vulve et le degré 3 un cordon extériorisé.

Il y a des formes non typiques de la procédance du cordon et en premier ce qu'on appelle le procubitus du cordon et qui correspond à la chute devant la présentation mais à membrane intacte, ce n'est pas une extrême urgence mais c'est une situation à très haut risque puisque dès qu'on aura la rupture de la poche des os, le cordon va être extériorisé. A la clinique, le diagnostic sera fait par la perception du cordon qui est irrégulier effuyant le doigt et animé par des battements toujours à travers la poche des os qui est toujours non rompue. Parfois, on a la chance de faire le diagnostic à l'échographie par la découverte à l'échographie de l'interposition du cordon entre la présentation et le col cervical et ceci grâce au doppler couleur.

La latéroscidence est une forme mineure de la procédance du cordon, c'est-à-dire correspondant à la chute du cordon en latéral par rapport à la présentation et de ce fait expose moins à la compression, ceci dit ça reste une urgence puisque la compression va survenir au cours de la descente de la tête et du mobile fœtal au niveau du bassin. Le diagnostic sera fait au toucher vaginal essentiellement par la perception de la partie distale du cordon latéralement par rapport à la présentation ou parfois lors de l'installation d'une souffrance fœtale qui va inciter l'examen

clinique ou au cours d'une échographie plus rarement. Donc là vous voyez les différentes images, donc là c'est une procédance qu'on appelle occulte qui est latérale, c'est la latérocidence, le schéma au milieu c'est une procédance du cordon mais avec le cordon qui est toujours au niveau de l'utérus, il est non extériorisé et la troisième avec l'extériorisation du col et donc ça correspond à la procédance complète.

Donc la prise en charge comme on a dit c'est une grande urgence obstétrique puisque la compression va entraîner une asphyxie périnatale du nouveau-né et donc il faut agir très rapidement par l'extraction immédiate par la voie la plus rapide, évidemment l'extraction sera faite dans un grand nombre de cas par césarien puisque c'est dans la majorité des cas la voie la plus rapide, cependant lorsque l'accouchement est imminent, notamment si la dilatation est complète et la présentation est déjà engagée, on peut aider par une extraction instrumentale pour faire l'accouchement de manière imminente et très rapide et qui sera fait dans la majorité des cas beaucoup plus rapidement qu'acheminer la patiente vers le bloc opératoire. Deuxième situation c'est la présentation de sièges, si la dilatation est complète et la présentation est déjà engagée, l'accouchement du siège est moins compressif que la tête fœtale et donc de ce fait là on peut accélérer l'accouchement et obtenir un accouchement par voie basse tout en préservant le pronostic fœtal. Dans tous les autres cas, il s'agit d'acheminer la patiente directement vers le bloc opératoire et réaliser une césarienne en urgence, évidemment lorsque l'on est dans la situation d'une procédance méconnue ou négligée, c'est à dire qui a déjà entraîné la mort fœtale, il n'y a plus lieu de réaliser cette césarienne sauf s'il y a une dystocie par exemple, un siège avec une macrosomie ou une autre indication obstétrique.

Il faut noter que le diagnostic de mort fœtale in utero dans ce contexte là devrait être confirmé par échographie puisque la palpation et la prise de poux au niveau du cordon est en général déconseillée et peut induire en erreur puisque parfois il y a un spasme au niveau du cordon et on peut dire qu'à la palpation le cordon n'est pas battant alors que le fœtus est toujours vivant et de ce fait là ne pas réaliser la césarienne et ne pas donner de chance à ce fœtus et à ce nouveau-né. Face à un procubitus du cordon ou à une latérocidence, c'est toujours la même attitude, c'est une césarienne prophylactique qu'il faut réaliser. En attendant et au cours de l'acheminement de la patiente au bloc opératoire, certaines mesures sont toujours de mise afin d'essayer de diminuer la compression du cordon et le retentissement sur le fœtus.

La première mesure c'est qu'il faut refouler la présentation et il y a un adage qui dit que celui qui fait le diagnostic de la procédance ne retire plus sa main puisqu'il va poser le diagnostic mais il va refouler la présentation, il va appeler de l'aide et ordonner l'acheminement de la patiente au bloc opératoire tout en maintenant la présentation refoulée, c'est à dire pour ne pas comprimer le cordon ombilical. Si le cordon est déjà extériorisé, à ce moment là il faut juste le protéger de la dessiccation en le mettant dans un champ stérile imbibé de sérum tiède. On peut aussi arrêter ou diminuer les contractions utérines qui vont augmenter la compression et la poussée de la tête en mettant en place une tocolyse rapide en attendant de réaliser la césarienne.

On peut aussi s'aider d'une position de trindelenbourg ou génie pectorale qui va aider au refoulement de la présentation. Il faut évidemment préparer l'accueil du nouveau-né, c'est à dire avertir le pédiatre, préparer la table de réanimation, puisqu'on s'attend le plus souvent à un nouveau-né en détresse, en asphyxie per partum, c'est à dire préparer sa réanimation. Troisième volet, c'est celui de la prévention et c'est le plus important, ça passe toujours par réaliser des amniotomies ou des ponctions sous contrôle du doigt à chaque fois qu'on est dans des situations à haut risque de procédance du cordon, c'est à dire lorsqu'il y a une mauvaise accommodation, lorsqu'il y a un hydramnios, à ce moment-là il faut toujours ponctionner et c'est dans cette situation où on va avoir ce qu'on appelle les poches bombantes et qui correspondent à une situation à haut risque de procédance, donc il ne faut pas remplir la poche des os au moment de la contraction, il faut toujours remplir en dehors de la contraction, lorsque la poche est bombante, il faut se contenter de ponctionner à l'aide d'une aiguille et de contrôler le débit par le doigt et non pas de faire une rupture franche et laisser couler de manière importante le liquide amniotique et de se faire exposer au risque.

L'idéal c'est de toujours faire la rupture de la poche des os après que la présentation ait occupé tout le détroit supérieur, c'est à dire après son application ou son engagement. Voilà donc la position génie pectorale qu'on peut réaliser, soit génie pectorale ou bien position Trendelenburg, c'est à dire la tête en bas pour favoriser la décompression du cordon ombilical. Le pronostic est en général dépendant de degrés de l'urgence, de degrés de la rapidité avec laquelle on a réalisé la césarienne, il dépend aussi d'autres paramètres, notamment de l'âge gestationnel, puisque lorsqu'il s'agit de prématurité, le pronostic de la prématurité va se rajouter au problème de la procédence et donc la morbidité et la mortalité néonatale va se trouver élevée, au type de présentation puisque par exemple lorsqu'on a une présentation de siège, elle est moins compressive, c'est à dire le pronostic va être plus bon, le délai entre la procédence et l'extraction est le paramètre peut-être le plus important et qui va permettre de réduire la mortalité, la morbidité néonatale et le mode d'extraction puisque la césarienne s'accompagne le plus souvent d'un faible taux de mortalité, la procédence du cordon est une pathologie qui va retentir sur le nouveau-né, mais aussi sur la femme, pas de manière indirecte, puisqu'il va augmenter les risques d'intervention en urgence, de réaliser des extractions instrumentales, de réaliser des césariennes et donc toute la morbidité qui est liée à ces actes médicaux.

En conclusion, c'est une urgence obstétricale type où le diagnostic et clinique doit être fait rapidement avec précision et les étapes de prise en charge doivent être adaptées rapide et en bonne coordination avec tous les membres de l'équipe, sages-femmes, obstétriciens, anesthésistes et pédiatres puisque de ça dépend le pronostic du nouveau-né et aussi de sa mère. Je vous remercie.